

lovastatina

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

lovastatina 10 mg. Embalagem contendo 30 comprimidos.

lovastatina 20 mg. Embalagem contendo 30 comprimidos.

lovastatina 40 mg. Embalagem contendo 10 comprimidos.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 10 mg contém:

lovastatina..... 10 mg

excipientes q.s.p. 1 comprimido

(butilhidroxianisol, lactose, amido, celulose microcristalina, estearato de magnésio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho)

Cada comprimido de 20 mg contém:

lovastatina..... 20 mg

excipientes q.s.p. 1 comprimido

(butilhidroxianisol, lactose, amido, celulose microcristalina, estearato de magnésio, indigotina laca)

Cada comprimido de 40 mg contém:

lovastatina..... 40 mg

excipientes q.s.p. 1 comprimido

(butilhidroxianisol, lactose, amido, celulose microcristalina, estearato de magnésio, indigotina laca, amarelo quinoleína laca)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Leia atentamente este texto antes de começar a tomar o medicamento, ele informa sobre as propriedades deste medicamento. Se persistirem dúvidas ou estiver inseguro fale com seu médico.

Antes de utilizar o medicamento, confira o nome do rótulo e não administre caso haja sinais de violação e/ou danos na embalagem.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

É um agente redutor de colesterol.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Este medicamento é utilizado como tratamento de manutenção a longo prazo, geralmente associado com uma dieta específica pobre em colesterol.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A **lovastatina** é contra-indicada nos casos de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, em pacientes com doenças do fígado, nos períodos de gravidez e amamentação e no tratamento concomitante com potentes inibidores da CYP3A4. Ao iniciar a terapia com **lovastatina** os pacientes devem ser avisados sobre o risco de miopatia e orientados a relatar prontamente dores musculares inexplicadas, dolorimento ou fraqueza.

Não há restrições quanto à alimentação em relação ao tratamento com a **lovastatina**. Entretanto, caso o seu médico tenha lhe prescrito uma dieta, siga-a corretamente.

“Informe ao médico ou cirurgião dentista o aparecimento de reações indesejáveis”.

“Informe ao médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento”.

“Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe seu médico se ocorrer gravidez ou se iniciar amamentação durante o uso deste medicamento”.

“Este medicamento causa malformação ao bebê durante a gravidez”.

**NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO,
PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE**

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

“Para dosagem: vide o item POSOLOGIA em INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE”.

“Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento”.

“Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico”.

“Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento. A data de fabricação e o prazo de validade estão impressos na embalagem externa do produto”.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

A **lovastatina** geralmente é bem tolerada. Raramente podem ocorrer flatulência, diarreia, constipação e náuseas durante o uso do medicamento.

Se ocorrerem sensações ou sintomas desagradáveis especialmente dor ou dolorimentos musculares, acompanhados ou não de febre ou mal-estar, o médico deverá ser avisado imediatamente.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

“Em caso de superdose procure um centro de controle de intoxicação ou socorro médico”.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco (15 – 30 °C), seco e ao abrigo da luz.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

A lovastatina é a lactona do ácido hidroxílico aberto correspondente na forma inativa, um potente inibidor da síntese endógena do colesterol sendo, portanto, um agente redutor do colesterol.

Farmacodinâmica

Após a absorção gastrointestinal a lovastatina é rapidamente hidrolisada para o hidroxiácido aberto, um inibidor competitivo da 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) redutase, uma enzima que catalisa uma etapa precoce e limitante na biossíntese do colesterol. Como resultado, em estudos clínicos, a lovastatina reduziu as concentrações de colesterol plasmático total, a lipoproteína de baixa densidade (LDL) e a lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) ligadas ao colesterol. Adicionalmente, a lovastatina aumentou moderadamente a lipoproteína de alta densidade (HDL) e reduziu os triglicérides plasmáticos. A forma ativa da lovastatina é um inibidor específico da HMG-CoA redutase, a enzima que catalisa a conversão de HMG-CoA para mevalonato. Em virtude dessa conversão ser uma etapa precoce na biossíntese do colesterol, não se espera que a terapia com a lovastatina cause acúmulo de esteróis potencialmente tóxicos. Além disso, a HMG-CoA é rapidamente metabolizada de volta a acetil-CoA, que participa de muitos processos biossintéticos do organismo. Em estudos com animais, após doses orais, a lovastatina demonstrou alta seletividade pelo fígado, onde atinge concentrações substancialmente mais altas do que nos demais tecidos. A lovastatina é largamente extraída na primeira passagem pelo fígado, seu local primário de ação, com subsequente excreção da droga pela bile. A lovastatina foi estudada no tratamento de hipercolesterolemia primária, quando a dieta apenas foi insuficiente. A lovastatina foi altamente eficaz na redução do LDL-colesterol e colesterol total, nas formas de hipercolesterolemia heterozigótica familiar e não-familiar, e na hiperlipidemia mista, quando o colesterol elevado era preocupante. Observou-se marcante resposta em duas semanas, e a resposta terapêutica máxima ocorreu em 4 a 6 semanas. A resposta foi mantida enquanto durou a terapia. Quando a terapia com a lovastatina foi interrompida, o nível de colesterol total retornou aos níveis anteriores ao tratamento. A lovastatina foi eficaz na hipercolesterolemia primária não-complicada de pacientes com diabetes do tipo I (insulino-dependente) bem controlado ou diabetes do tipo II (não-insulino dependente). As reduções dos lípides plasmáticos foram semelhantes às relatadas em populações não-diabéticas. O controle da glicose não foi afetado adversamente. Em estudos clínicos, a lovastatina retardou a progressão da arteriosclerose coronariana, com ou sem terapia concomitante com colestipol.

Farmacocinética

Os estudos mostraram os seguintes resultados:

- administrada por via oral, sua absorção é reduzida aproximadamente em 30% quando administrada com estômago vazio.
- a ligação às proteínas é alta (mais de 95%)
- sofre biotransformação rápida, dando por hidrólise vários metabólitos, inclusive a forma ativa, que é o beta-hidroxiácido.
- meia-vida: 3 horas
- atinge a concentração máxima em 2 a 4 horas
- duração da ação: 4 a 6 semanas.
- atravessa as barreiras hematoencefálica e placentária
- é excretada principalmente (83%) pelas fezes e parcialmente (10%) pela urina.

INDICAÇÕES

- Redução dos níveis elevados de colesterol total e LDL-colesterol em pacientes com hipercolesterolemia primária quando a resposta à dieta e a outras medidas não-farmacológicas isoladas forem inadequadas. A **lovastatina** reduz o colesterol total e o LDL-colesterol e aumenta

o HDL-colesterol; portanto, a **lovastatina** reduz a relação colesterol total / HDL-colesterol e LDL-colesterol / HDL-colesterol.

- Redução dos níveis elevados de colesterol em pacientes com hipercolesterolemia combinada e hipertriglicerimia, quando a hipercolesterolemia for a anormalidade mais preocupante.
- Para retardar a progressão da aterosclerose coronariana em pacientes com doenças arterial coronariana.

CONTRA-INDICAÇÕES

- *Hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da fórmula.*
- *Doença hepática ativa ou aumentos persistentes ou inexplicados das transaminases séricas.*
- *Gravidez e lactação (veja ADVERTÊNCIAS).*
- *Administração concomitante com potentes inibidores da CYP3A4, como por exemplo itraconazol, cetoconazol, inibidores da protease do HIV, eritromicina, claritromicina, telitromicina e nefazodona.*

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO

O medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco (15 – 30 °C), seco e ao abrigo da luz.

POSOLOGIA

O paciente deve iniciar uma dieta padrão para redução do colesterol, antes de receber **lovastatina**, e deve continuar a dieta durante o tratamento com **lovastatina**.

Hipercolesterolemia: a dose inicial recomendada é de 20 mg por dia, administrados em uma única dose, com a refeição noturna. Doses diárias únicas dadas com a refeição noturna foram mais eficazes do que a mesma dose dada com a refeição matinal, talvez porque o colesterol seja sintetizado principalmente à noite. Pacientes com hipercolesterolemia leve a moderada podem ser tratados inicialmente com 10 mg de **lovastatina**. Ajustes posológicos, se necessários, devem ser feitos a intervalos não inferiores a 4 semanas, até o máximo de 80 mg por dia, em uma única dose ou em doses divididas nas refeições diurna e noturna. Doses divididas (por exemplo, duas vezes ao dia) tendem a ser ligeiramente mais eficazes do que únicas diárias.

A posologia de **lovastatina** deve ser reduzida se o LDL-colesterol atingir níveis inferiores a 75 mg/dL ou se o colesterol plasmático total atingir níveis inferiores a 140 mg/dL.

Aterosclerose coronariana: nos estudos de aterosclerose coronariana utilizando **lovastatina**, com ou sem terapia concomitante, as posologias utilizadas foram 20 a 80 mg/dia, administradas em dose única ou doses divididas. Nos dois estudos onde foi somente utilizado **lovastatina**, a dose era reduzida se o nível do colesterol total plasmático atingisse valores inferiores a 110 mg/dL ou se o LDL-colesterol atingisse valores inferiores a 80 mg/dL, respectivamente.

Terapia concomitante: A **lovastatina** é eficaz isolada ou associada a seqüestranes de sais biliares.

Em pacientes submetidos a tratamento concomitante com ciclosporina, danazol, genfibrozil, outros fibratos ou doses hipolipemiantes de niacina (≥ 1 g/dia), a dose de **lovastatina** normalmente não deve exceder 20 mg/dia.

Em pacientes tomando amiodarona ou verapamil concomitantemente com **lovastatina**, a dose de **lovastatina** não deve exceder 40 mg/dia (veja ADVERTÊNCIAS, Efeitos musculares).

Posologia na insuficiência renal: A **lovastatina** não sofre excreção renal significativa, portanto modificações posológicas não devem ser necessárias em pacientes com insuficiência renal moderada.

Em pacientes com insuficiência renal grave (depuração plasmática de creatinina < 30 mL/min), dose acima de 20 mg/dia devem ser cautelosamente consideradas e, se for de extrema necessidade, implementadas com cautela (veja ADVERTÊNCIAS, Efeitos musculares).

ADVERTÊNCIAS

Efeitos musculares: A **lovastatina** e outros inibidores da HMG-CoA redutase ocasionalmente causam miopatia, que se manifesta como dor muscular ou fraqueza associada a grandes aumentos da creatinina quinase (CK) (> 10 vezes o limite superior da normalidade [LSN]). Rabdomiólise, com ou sem insuficiência renal aguda secundária à mioglobulinúria, foi raramente relatada e pode ocorrer em qualquer momento. Em uma Avaliação Clínica Expandida de **lovastatina** (estudo EXCEL), houve 1 caso de miopatia entre 4.933 pacientes distribuídos do modo randômico para tratamento com 20-40 mg de **lovastatina** diariamente por 48 semanas e 4 entre os 1.649 pacientes que receberam 80 mg diariamente. Quando o tratamento com a droga foi interrompido ou descontinuado nestes pacientes, os sintomas musculares e aumentos de CK foram prontamente resolvidos. O risco de miopatia aumenta com a terapia concomitante com certas drogas, algumas das quais foram excluídas pelo protocolo do estudo EXCEL.

A dose de **lovastatina** não deve exceder 20 mg/dia em pacientes que também estão sendo tratados com danazol, genfibrozil, outros fibratos ou doses hipolipemiantes de niacina (≥ 1 g / dia). O uso concomitante de **lovastatina** e genfibrozil deve ser evitado, a menos que seja provável que os benefícios de alterações posteriores nos níveis lipídicos compensem o aumento do risco que está associado a essa combinação de substâncias. Os benefícios do uso de **lovastatina** em pacientes que tomam outros fibratos, niacina, ciclosporina ou danazol deverá ser cuidadosamente considerado em relação ao aumento do risco associado à utilização destas combinação de fármacos.

O uso de **lovastatina** em doses superiores a 40 mg/dia deverão ser evitadas se verapamil ou amiodarona estão sendo utilizados, a menos que seja provável que os benefícios clínicos superem o aumento do risco de miopatia.

Miopatia causada por interações medicamentosas: A incidência e gravidade da miopatia aumentou com a administração concomitante de inibidores da HMG-CoA redutase com drogas que podem causar miopatia quando administradas isoladamente, tais como genfibrozil e outros fibratos e com doses hipolipemiantes (>1 g/dia) de niacina (ácido nicotínico). Além disso, o risco de miopatia parece aumentar com níveis altos de atividade inibitória da HMG-CoA redutase no plasma. A **lovastatina** e outros inibidores da HMG-CoA redutase são metabolizados pela isoforma 3A4 do citocromo P450. Certas drogas que em doses terapêuticas possuem efeito inibitório significativo desta via metabólica podem elevar substancialmente os níveis plasmáticos de inibidores da HMG-CoA redutase e assim aumentar o risco de miopatia. Estas drogas incluem ciclosporina, o bloqueador do canal de cálcio da classe dos tetralol, mibefradil, itraconazol, cetoconazol e outros antifúngicos azólicos, os antibióticos macrolídeos, eritromicina e claritromicina e o antidepressivo nefazodona.

Reduzindo o risco de miopatia:

1. Medidas gerais: ao iniciar a terapia com **lovastatina** os pacientes devem ser avisados sobre o risco de miopatia e orientados a relatar prontamente dores musculares inexplicadas, dolorimento ou fraqueza. Níveis de CK acima de 10 vezes o LSN em um paciente com sintomas musculares inexplicados indicam miopatia. A terapia com **lovastatina** deve ser descontinuada diante do diagnóstico ou da suspeita de miopatia. Na maioria dos casos, quando os pacientes interrompem imediatamente o tratamento, os sintomas musculares e os aumentos de CK desapareceram.

Dos pacientes com rabdomiólise, muitos apresentaram história clínica complicada. Alguns apresentavam insuficiência renal pré-existente, geralmente como consequência de diabetes de longa data. Em tais pacientes, aumentos da dose requerem cautela. Da mesma forma, como não há consequências adversas conhecidas da breve interrupção da terapia em certos períodos, o

tratamento com **lovastatina** deve ser suspenso alguns dias antes de uma cirurgia eletiva de grande porte e diante do aparecimento de qualquer condição aguda grave, médica ou cirúrgica.

2. Medidas para reduzir o risco de miopatia causada por interações medicamentosas: diante da consideração de combinar **lovastatina** e qualquer das drogas que interagem com ela os médicos devem pesar os benefícios potenciais e os riscos e devem monitorizar cuidadosamente seus pacientes para quaisquer sinais e sintomas de dor muscular, dolorimento ou fraqueza, particularmente durante os meses iniciais de terapia e durante os períodos de titulação ascendente de dose de cada droga. Determinações periódicas da CK podem ser consideradas em tais situações, mas não há garantia de que tal monitorização irá prevenir miopatia. O uso combinado de **lovastatina** com fibratos ou niacina deve ser evitado a menos que o benefício de alterações adicionais nos níveis lipídicos possam superar os riscos aumentados desta combinação de drogas. Combinações de fibratos ou niacina com baixas doses de **lovastatina** tem sido usadas sem ocorrência de miopatia em estudos clínicos pequenos, de curta duração e adequadamente monitorizados. A adição destas drogas e inibidores da HMG-CoA redutase tipicamente proporciona redução adicional muito discreta do LDL colesterol, mas reduções adicionais de triglicérides e aumentos adicionais de HDL colesterol podem ser obtidos. Se uma destas drogas tiver que ser usada com a **lovastatina**, a experiência clínica sugere que o risco de miopatia é menor com a niacina do que com os fibratos.

Em pacientes recebendo concomitantemente ciclosporina, fibratos ou niacina, a dose de **lovastatina** deve geralmente não exceder 20 mg (veja POSOLOGIA, Terapia concomitante), já que o risco de miopatia aumenta substancialmente com doses mais altas. A interrupção da terapia com **lovastatina** durante tratamento com antifúngico azólico sistêmico ou um antibiótico macrolídeo deve ser considerada. O uso concomitante com outros medicamentos que em doses terapêuticas sabidamente possuem efeito inibitório significativo no citocromo P450 3A4 deve ser evitado a menos que os benefícios da terapia combinada superem o risco aumentado.

Efeitos hepáticos: Nos primeiros estudos clínicos, aumentos importantes das transaminases (superiores a 3 vezes o LSN) ocorreram em poucos pacientes, geralmente após 3 a 12 meses do início da terapia com **lovastatina**, mas sem desenvolvimento de icterícia ou outros sinais, ou sintomas clínicos. Não houve evidência de hipersensibilidade. Foi feita biópsia hepática em um desses pacientes e constatou-se hepatite focal discreta. Alguns desses pacientes tinham função hepática alterada antes da introdução da **lovastatina** e/ou consumiam quantidades consideráveis de álcool. Nos pacientes nos quais a terapia foi interrompida ou suspensa por causa do aumento das transaminases, inclusive no paciente submetido à biópsia, os níveis de transaminases voltaram lentamente aos níveis pré-tratamento.

No estudo EXCEL de 48 semanas, que envolveu 8.245 pacientes, a incidência de aumentos importantes (acima de 3 vezes o LSN) das transaminases em testes sucessivos foi de 0,1% para o placebo, e de 0,1% para a posologia de 20 mg/dia, 0,9% para 40 mg/dia e 1,5% para 80 mg/dia de **lovastatina**.

Recomenda-se a realização de dosagens das transaminases antes do início do tratamento e periodicamente durante o tratamento, em especial naqueles pacientes que têm teste de função hepática alterado e/ou que consomem quantidades substanciais de álcool, e em pacientes nos quais a dose é aumentada para 40 mg/dia ou mais. Se as transaminases se elevam acima de três vezes o LSN, o risco potencial de continuar o tratamento com **lovastatina** deve ser contraposto aos benefícios esperados com o seu uso. Dosagens de transaminases devem ser repetidas imediatamente; se os aumentos forem persistentes ou progressivos, a droga deve ser interrompida.

À semelhança de outros agentes hipolipemiantes, foram relatados aumentos moderados das transaminases (menores do que 3 vezes o LSN) durante a terapia com **lovastatina** (veja REAÇÕES ADVERSAS). Essas alterações apareceram logo após o início da terapia com **lovastatina**, foram geralmente transitórias e não foram acompanhadas por quaisquer sintomas; não foi necessária a interrupção do tratamento. A droga deve ser usada com cautela em pacientes com história de doença hepática. Hepatopatia ativa é uma contra-indicação para o uso de **lovastatina** (veja CONTRA-INDICAÇÕES).

Avaliações oftalmológicas: Mesmo na ausência de qualquer terapia medicamentosa, é possível que com o tempo ocorra um aumento na prevalência de opacidades do cristalino como resultado do envelhecimento. Dados atuais de estudos clínicos de longo prazo não indicam efeitos adversos da **lovastatina** no cristalino de seres humanos.

Gravidez: A **lovastatina** é contra-indicada na gravidez.

A aterosclerose é um processo crônico e a descontinuação de agentes hipolipemiantes durante a gravidez deve ter pequeno impacto no resultado do tratamento a longo prazo da hipercolesterolemia primária. Ainda, o colesterol e outros produtos da biossíntese do colesterol são componentes essenciais para o desenvolvimento do feto, incluindo a síntese de esteróides e das membranas celulares. Devido à capacidade dos inibidores da HMG-CoA redutase, tais como a **lovastatina**, de diminuir a síntese do colesterol e possivelmente de outros produtos da cadeia biossintética, a **lovastatina** é contra-indicada na gravidez. A **lovastatina** deve ser administrada a mulheres férteis somente quando essas pacientes não tiverem probabilidade mínima de conceber. Se a paciente ficar grávida enquanto estiver usando a droga, o tratamento deverá ser interrompido imediatamente e a paciente deve ser informada acerca dos riscos possíveis para o feto. Há alguns relatos de anomalias congênitas em bebês cujas mães foram tratadas com inibidores de HMG-CoA redutase durante a gravidez (veja CONTRA-INDICAÇÕES). Em uma revisão do acompanhamento prospectivo de aproximadamente 100 gestações em mulheres expostas a **lovastatina** ou outro inibidor da HMG-CoA redutase estruturalmente relacionado, a incidência de anormalidades congênitas, abortos espontâneos e morte fetal / natimortos não excedeu o previsto para população em geral. Como a segurança em gestantes não foi estabelecida e não há benefício aparente para terapia com **lovastatina** durante a gravidez, o tratamento deve ser imediatamente descontinuado ao se confirmar a gravidez.

Nutrízes: Não se sabe se a **lovastatina** é excretada no leite humano. Pelo fato de muitas drogas serem excretadas no leite e devido ao seu potencial para reações adversas graves em lactentes, as pacientes que usam **lovastatina** não devem amamentar suas crianças (veja CONTRA-INDICAÇÕES).

Uso pediátrico: A segurança e a eficácia em crianças não foram estabelecidas.

Uso em idosos: Em um estudo controlado em pacientes idosos, com idade acima de 60 anos, a eficácia pareceu ser semelhante à observada na população em geral e não houve aumento aparente na frequência de achados adversos clínicos e laboratoriais.

Hipercolesterolemia familiar homozigótica: Em pacientes com a rara hipercolesterolemia familiar homozigótica, a **lovastatina** é menos eficaz, possivelmente porque esses pacientes não têm receptores de LDL funcionais. A **lovastatina** parece causar mais frequentemente aumentos de transaminases nesses pacientes homozigóticos (veja REAÇÕES ADVERSAS).

Hipertrigliceridemia: A **lovastatina** tem efeito moderadamente redutor dos triglicérides e não é indicado quando a hipertrigliceridemia for a anormalidade mais importante (isso é, hiperlipidemia tipos I, IV e V).

“Este medicamento causa malformação ao bebê durante a gravidez”.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO

Gravidez e lactação: A **lovastatina** é contra-indicada na gravidez (veja ADVERTÊNCIAS).

Uso pediátrico: A segurança e a eficácia em crianças não foram estabelecidas.

Uso em idosos: Veja ADVERTÊNCIAS.

Doença hepática ativa ou aumentos persistentes ou inexplicados das transaminases séricas: A hepatopatia ativa é uma contra-indicação para o uso de **lovastatina**

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O risco de rabdomiólise aumenta com o uso concomitante de **lovastatina** com drogas que, em doses terapêuticas, possuem efeito inibitório significativo no citocromo P450 3A4 tais como ciclosporina, mibefradil, itraconazol, cetoconazol, eritromicina, claritromicina e nefazodona ou com derivados do ácido fíbrico ou niacina (veja ADVERTÊNCIAS, Efeitos Musculares).

Derivados cumarínicos: Quando a **lovastatina** e anticoagulantes cumarínicos são administrados concomitantemente, o tempo de protrombina pode aumentar em alguns pacientes. Recomenda-se a determinação do tempo de protrombina de pacientes que estejam recebendo anticoagulantes antes do início da terapia com **lovastatina** e sempre que necessário durante os primeiros dias de terapia, para assegurar a não-ocorrência de alterações significativas no tempo de protrombina. Uma vez que tenha sido documentado um tempo de protrombina estável, os tempos de protrombina podem ser monitorizados a intervalos normalmente recomendados para pacientes tratados com anticoagulantes cumarínicos. Se a dose de **lovastatina** é alterada, o mesmo procedimento deve ser repetido. A terapia com **lovastatina** não tem sido associada com sangramento ou com alterações no tempo de protrombina em pacientes que não estejam tomando anticoagulantes.

Ciclosporina

O risco de miopatia/rabdomiólise aumenta na administração concomitante de ciclosporina, especialmente com doses elevadas de **lovastatina**. Portanto, a dose de **lovastatina** não deve exceder 20 mg/dia em pacientes em tratamento concomitante com ciclosporina. Embora não se conheça completamente o mecanismo, a ciclosporina aumenta a AUC do ácido de **lovastatina**, provavelmente em parte devido à inibição do CYP3A4.

Danazol

O risco de miopatia e rabdomiólise aumenta na administração concomitante de danazol com doses elevadas de **lovastatina**.

Interações com medicamentos hipolipemiantes, que podem causar miopatia quando administrados isoladamente

O risco de miopatia, incluindo rabdomiólise, aumenta com a administração dos seguintes medicamentos hipolipemiantes, que não são potentes inibidores do CYP3A4, mas que podem causar miopatia quando administrados isoladamente: gemfibrozil, outros fibratos e niacina (ácido nicotínico) ($\geq 1\text{g/dia}$).

Interações associadas ao citocromo P450 3A4

A **lovastatina** não tem nenhum efeito inibidor sobre citocromo P450 3A4. Portanto, não é esperado que a **lovastatina** tenha influência nas concentrações plasmáticas dos medicamentos metabolizados através do citocromo P450 3A4. No entanto, a **lovastatina** é um substrato do citocromo P450 3A4. Potentes inibidores do citocromo P450 3A4 podem aumentar o risco de miopatia e rabdomiólise através do aumento da atividade inibitória da concentração da HMG - CoA redutase no plasma durante o tratamento com **lovastatina**. Esses inibidores incluem itraconazol, cetoconazol, eritromicina, claritromicina, telitromicina, inibidores da protease do HIV e nefazodona.

Portanto, a combinação destes potentes inibidores da CYP3A4 está contra-indicada.

Se o tratamento com itraconazol, cetoconazol, eritromicina, claritromicina, telitromicina, inibidores da protease do HIV e nefazodona for inevitável, o tratamento com **lovastatina** deverá ser interrompida durante o tratamento.

Amiodarona e verapamil

O risco de miopatia e rabdomiólise aumenta na administração concomitante de amiodarona ou

verapamil com doses elevadas de inibidores relacionados à HMG - CoA redutase. Portanto, doses de **lovastatina** não devem exceder 40 mg/dia em pacientes que são tratados concomitantemente com amiodarona ou verapamil, salvo se for plausível que os efeitos clínicos benéficos superam o risco aumentado de miopatia e rabdomiólise

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

*A **lovastatina** é geralmente bem tolerada; em geral, as experiências adversas foram de natureza leve e transitória.*

Em estudos clínicos controlados, as experiências adversas (consideradas possível, provável ou definitivamente relacionadas à droga) que ocorreram com frequência maior do que 1% foram: flatulência, diarreia, constipação, náusea, dispepsia, tontura, visão embaçada, cefaléia, câibras, mialgia, erupções cutâneas e dor abdominal. Os pacientes que recebem droga ativa tiveram incidência igual ou maior de reações adversas gastrointestinais em comparação aos que tomaram placebo. Outras experiências adversas que ocorreram com incidência de 0,5% a 1% foram: fadiga, prurido, boca seca, insônia, alterações do sono e distúrbios do paladar. Miopatia e rabdomiólise foram raramente relatadas.

*Em uma avaliação clínica expandida de 48 semanas com **lovastatina** comparando-a com o placebo, as experiências adversas relatadas foram semelhantes àsquelas dos primeiros estudos clínicos, e a incidência com droga e placebo não foi estatisticamente diferente. As seguintes experiências adversas foram relatadas desde a comercialização do medicamento: hepatite, icterícia colestática, vômitos, anorexia, parestesia, neuropatia periférica, distúrbios psíquicos (incluindo ansiedade), alopecia, eritema multiforme (incluindo síndrome de Stevens-Johnson) e necrólise epidérmica tóxica. Raramente foram relatadas pancreatite e desordens do sistema imunológico, que inclui alguns dos seguintes achados: anafilaxia, angioedema, lúpus – como síndrome, polimialgia reumática, dermatomiosite, vasculite, trombocitopenia, leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, fator antinúcleo positivo, VSH elevada, artralgia, artrite, urticária, astenia, fotossensibilidade, febre, vermelhidão, calafrios, dispnéia e mal-estar.*

Achados laboratoriais: Raramente foram relatados aumentos importantes e persistentes das transaminases séricas (veja ADVERTÊNCIAS). Foram relatadas alterações de outros testes de função hepática incluindo elevação de fosfatase alcalina e de bilirrubina. Foram relatados aumentos nos níveis de creatinina quinase (CK) (atribuíveis à fração não-cardíaca da CK). Esses efeitos têm sido geralmente leves e transitórios, e raramente foram reportados aumentos intensos (veja ADVERTÊNCIAS, Efeitos musculares).

SUPERDOSE

Até que se tenha mais experiência, não é possível recomendar tratamento específico para a superdosagem com **lovastatina**. Devem ser adotadas medidas gerais e a função hepática deve ser monitorizada. A capacidade dialisável da **lovastatina** e dos seus metabólitos em seres humanos não é ainda conhecida. Cinco voluntários humanos sadios receberam dose de até 200 mg de **lovastatina** em uma única dose, sem experiências adversas clinicamente significativas. Foram relatados poucos casos de superdosagem acidental; nenhum paciente apresentou sintomas específicos e todos se recuperaram sem seqüelas. A dose máxima ingerida foi de 5-6 g.

“Para sua segurança, não descarte a bula e o cartucho até o uso total deste medicamento”.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

Reg. M.S.: 1.0047.0393

Farm. Resp.: Luciana A. Perez Bonilha
CRF-PR nº 16.006

Logo SAC 0800 4009192



Fabricado por:
Salutas Pharma GmbH
Barleben – Sachsen-Anhalt
Alemanha

Importado por:
Sandoz do Brasil Ltda.
Rod. Celso Garcia Cid (PR-445), Km 87
Cambé-PR
CNPJ: 61.286.647/0001-16
Indústria Brasileira